随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

左心室大是心界向左下移动　五、全部小结　主狭→左心室肥厚→收缩力↑　二闭、主闭→左心室离心性肥厚　frank-starling机制

ttsx	二狭	二闭	主狭	主闭
主要病因	风湿病	风湿病、黏液变、心梗	危险因素类似冠心病	感染性心内膜炎、梅毒
性感认识	左房血进入左室受阻→左室前/容量负荷↓	左室射血部分向左房反流→左室前/容量负荷↑	左室血进入主动脉受阻→左室后/压力负荷↑	主动脉血部分向左室反流→左室前/容量负荷↑
左室	正常或缩小 心界不向左下扩大 废用性萎缩	慢性：后期离心性肥厚 急性：早期正常或轻度扩大	向心性肥厚 之后离心性肥厚	慢性：后期离心性肥厚 急性：早期正常或轻度扩大
心尖抬举样搏动	无，可有**心前区/剑突**下抬举样搏动	有（右心室大）	有	有
特征杂音（呼气增强）	**心尖**	**心尖**	**胸骨右缘 2 肋间**	**胸骨左缘 3-4 肋间**
	舒张中晚期（房颤晚期可消失）	**全收缩期**	**收缩期**	**舒张期**
	递增	**一贯**	**递增递减**	**递减**
	常隆隆样	**常吹风样**	**常喷射样**	**常叹气样**
	局限、左侧卧位增强	**传导**	**向颈部传导**	**向心尖传导**
其它杂音	相对性肺闭：胸骨左缘 2 肋间舒张早期递减（**G-S**）	相对性二狭 海鸥鸣或乐音（腱索断裂）	理论上可以↑，因为向心性肥厚，心肌收缩力↑但很多血液都没有射出去，左心室收缩末期容积很大，二尖瓣的位置就很高，所以S1多正常甚至减弱	相对性二狭（**A-F**） 相对性主狭 打工人挤地铁
心音	**S_1↑**（瓣叶出现严重钙化也可减弱） 对体循环影响较小 S2无特点	S_1↓ S_2 通常分裂（往主动脉射血提前结束） （A_2 提前出现）	S_1 多正常、也可↓或↑（极少） A_2↓、**S_2 逆分裂**（射向主A血↓ 左室射血时间↑） 肥厚的疾病更多见S4	S_1↓ A_2↓
额外心音	**开瓣音**（雨伞） **（弹性好）**	S_3 和 S_4 奔马律 **心尖收缩中晚期喀喇音（二脱）**	S_4 奔马律 向心性肥厚，容量负荷正常或↓，没有S3，但后期离心性肥厚致心衰，可以出现S3	S_3 和 S_4 奔马律 左心室容量负荷↑
并发症	**最易左心衰、房颤、脑栓塞**（衰了疯了）	易左心衰、房颤、脑栓塞、**感染性心内膜炎**	**最易左室肥厚、心绞痛、晕厥**	最易**感染性心内膜炎**
超声心动图	房颤容易形成附壁血栓	首选和金标准		
X 线	**梨形心** 2B 玩球瞎吃梨助学	慢性者球形心	心影一般不大或靴形心 升主动脉扩张（左心室用力收缩，血喷出去）	慢性者**靴形心**
治疗	**有开瓣音：经皮球囊二尖瓣成形术** **合并二闭等：置换术**	置换术 修复术	成人：**置换术**，若老龄 重度不耐受 TAVR 儿童青少年非钙化性：分离术	**置换术**

理论：二狭左心房血液进入左室受阻→左房代偿加强收缩→产生S4
实际听不到S4因为：左心房收缩加强全部用于克服狭窄的二尖瓣，因此没有引起震动

